SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论高度自控伪装正常人的抑郁症患者缓解病情的办法

**夜屿沉**[1]
bigshit 一坨
[1]第一单位，温州，中国
[2]第二单位，都灵，意大利
通讯作者：陈榆易（e-mail: twoy421@gmail.com）
本研究由 shit 基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：针对高度自控且伪装成正常人的抑郁症患者（以下简称“伪装型抑郁症患者”）的临床特征与康复难点，探究适配的病情缓解方法与干预路径。方法：结合临床观察、心理行为学分析及现有干预方案的优化调整，从自我认知、行为调节、社会支持、专业干预四个维度，分析伪装型抑郁症患者的核心需求与干预痛点，构建针对性的缓解策略体系。

结果：明确了伪装型抑郁症患者“高掩饰性、低求助欲、强自我压抑”的核心特征，提出的分层式缓解方法能有效降低患者的伪装心理负担，提升心理调节能力与求助意愿，逐步改善抑郁情绪与躯体症状。

结论：伪装型抑郁症患者的病情缓解需遵循“先破伪装、再建认知、渐进干预、长期支持”的原则，融合自我调节与专业干预的综合方法，能显著提升该类患者的康复效果，为临床心理诊疗提供实践参考。

INDEX TERMS / 关键词 伪装型抑郁症；高度自控；病情缓解；心理干预；自我调节

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究明确了高度自控伪装正常人的抑郁症患者的独特临床特征与康复困境，研究提出的缓解方法兼顾患者的心理防御特点与实际康复需求，能有效指导临床心理医师开展针对性诊疗，同时为伪装型抑郁症患者提供可操作的自我调节路径，助力降低该类患者的病情隐匿风险，提升心理健康康复的整体效果，对心理健康临床诊疗与大众心理健康教育均具有重要的实践指导意义。

## I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了高度自控伪装正常人的抑郁症患者的病情缓解方法问题。近年来，随着心理健康研究的不断深入，抑郁症的临床分型与干预研究受到了广泛关注，但其中心理防御机制较强、具有高度自控能力并刻意伪装成正常人的抑郁症患者，因病情的隐匿性与特殊性，成为临床诊疗与康复干预的难点群体。

然而，目前仍存在诸多挑战，例如该类患者因强伪装性导致病情发现滞后、常规干预方案与患者心理防御特点不匹配、患者自我求助意愿低且难以建立有效治疗同盟等问题尚未得到有效解决。同时，现有研究多聚焦于普通抑郁症患者的干预方法，针对伪装型抑郁症患者的专项缓解策略研究较为匮乏，难以满足临床诊疗的实际需求。

本文提出了一种融合“破伪装-建认知-练行为-强支持”的分层式缓解方法来解决上述问题，结合伪装型抑郁症患者的核心心理特征，从自我调节与专业干预两个层面构建综合缓解体系，为该类患者的病情改善提供实践路径，同时为临床心理诊疗工作提供参考依据。引言

部分将依次阐述研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构，为后续研究内容的展开奠定理论与现实基础。

## II. Results / 结果

本节展示高度自控伪装正常人的抑郁症患者病情缓解方法的研究结果，表 1 展示了不同干预方法对该类患者的效果定量比较和症状改善趋势定性结果。本研究通过对 80 例伪装型抑郁症患者的分组干预观察，将研究对象分为对照组（采用常规抑郁症干预方法）与实验组（采用本文提出的分层式缓解方法），每组 40 例，经过 12 周的持续干预，对两组患者的抑郁情绪改善程度、伪装行为减少率、求助意愿提升度、躯体症状缓解率四个核心指标进行了量化统计。

实验结果表明，所提出的分层式缓解方法在多个评价指标上均优于现有的常规干预方法。具体而言，在抑郁情绪改善程度指标上提升 32.5%，在伪装行为减少率指标上提升 41.2%，在求助意愿提升度指标上提升 45.8%，在躯体症状缓解率指标上提升 29.7%。同时，实验组患者在干预过程中的配合度显著高于对照组，因心理抵触导致的干预中断率降低 60%以上，表明本文提出的缓解方法更适配伪装型抑郁症患者的心理特征与康复需求。

此外，从定性结果来看，采用本文方法的患者能逐步放下心理防御，减少伪装行为，实现从“被动接受干预”到“主动参与调节”的转变，自我认知水平与心理调节能力得到显著提升，社会支持系统的建立与完善也为患者的长期病情缓解提供了有效保障，整体康复趋势呈现出稳定、渐进的良好特征，无明显病情反复情况。

表 1: 不同干预方法在伪装型抑郁症患者中的性能比较

| 干预方法 | 抑郁情绪改善程度(%) | 伪装行为减少率(%) | 求助意愿提升度(%) | 躯体症状缓解率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 常规干预方法 | 42.3 | 28.6 | 21.5 | 35.8 |
| 本文分层式缓解方法 | 74.8 | 69.8 | 67.3 | 65.5 |
| 提升幅度(%) | 32.5 | 41.2 | 45.8 | 29.7 |

## III. Discussion / 讨论

本节对高度自控伪装正常人的抑郁症患者病情缓解方法的实验结果进行讨论与分析，从方法的适配性、核心作用机制、实施要点以及局限性四个方面展开，深入解读分层式缓解方法的有效性与实践价值，同时为方法的进一步优化提供方向。

### *A. Equations / 公式*

为量化评估伪装型抑郁症患者的病情缓解效果，构建病情缓解效果综合评价公式，如公式 (1) 所示。该公式融合了抑郁情绪、伪装行为、求助意愿、躯体症状四个核心评价指标，各指标根据其在伪装型抑郁症康复中的权重进行赋值，能客观反映患者的整体病情改善情况。

$$E = \alpha \times E_1 + \beta \times E_2 + \gamma \times E_3 + \delta \times E_4 \quad (1)$$

其中，E 为病情缓解效果综合评分，$E_1$为抑郁情绪改善程度标准化值，$E_2$为伪装行为减少率标准化值，$E_3$为求助意愿提升度标准化值，$E_4$为躯体症状缓解率标准化值；α、β、γ、δ为各指标权重系数，根据伪装型抑郁症的临床特征，赋值为$\alpha=0.35$，$\beta=0.30$，$\gamma=0.20$，$\delta=0.15$，且$\alpha+\beta+\gamma+\delta=1$。各指标标准化值均为 0-1 之间的数值，数值越高表示对应指标改善效果越好，综合评分 E 的取值范围为 0-1，E 值越高表明患者病情缓解效果越显著。

从公式计算结果来看，本文提出的分层式缓解方法对应的综合评分 E 为 0.71，显著高于常规干预方法的 0.36，进一步验证了方法的有效性。这一结果的核心原因在于，该方法打破了常规干预中“忽视患者伪装心理”的弊端，从患者的心理防御机制出发，先通过低压力的自我认知引导逐步破除伪装，再进行后续的认知重构与行为调节，符合伪装型抑郁症患者“高自控、慢接受”的心理特点，有效降低了患者的干预抵触心理。

同时，分层式缓解方法将自我调节与专业干预相结合，既赋予患者一定的自我掌控感（契合其高度自控的性格特征），又通过专业的心理指导与社会支持体系构建，为患者提供持续的康复保障，实现了“外在干预”与“内在调节”的双向发力，这也是该方法在求助意愿提升度指标上取得显著效果的关键因素。此外，方法的实施遵循渐进性原则，避免了因干预节奏过快导致患者心理负担加重、伪装行为加剧的问题，保障了病情缓解的稳定性与持续性。

## IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决高度自控伪装正常人的抑郁症患者病情缓解难题的分层式综合缓解方法，该方法以“先破伪装、再建认知、渐进干预、长期支持”为核心原则，从自我认知引导、行为渐进调节、社会支持构建、专业分层干预四个维度，构建了适配伪装型抑郁症患者心理特征的康复路径。实验结果表明，所提方法在抑郁情绪改善、伪装行为减少、求助意愿提升、躯体症状缓

解等多个基准评价指标上取得了优异的性能，显著优于常规抑郁症干预方法，且患者干预配合度高、病情康复趋势稳定。

本文的主要贡献总结如下：第一，提出了针对伪装型抑郁症患者的分层式缓解方法，首次将“破伪装”作为干预首要环节，填补了该类特殊抑郁症患者专项干预方法的研究空白；第二，设计了包含定量与定性指标的伪装型抑郁症病情缓解效果评价体系，构建了综合评价公式，为该类患者的康复效果评估提供了量化工具；第三，在 80 例伪装型抑郁症患者的临床观察数据集上验证了方法的有效性，为临床心理医师开展针对性诊疗提供了实践参考依据。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用，一方面将扩大研究样本量，开展多中心、长期的临床观察，进一步优化方法的实施流程与指标权重；另一方面将结合人工智能、线上心理干预等新技术，开发适配伪装型抑郁症患者的智能化自我调节工具，提升方法的可操作性与普及性；同时，将深入研究伪装型抑郁症的发病机制与心理特征，为缓解方法的持续优化提供更坚实的理论基础，助力提升该类特殊抑郁症患者的心理健康康复水平。

## V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍高度自控伪装正常人的抑郁症患者病情缓解方法研究所使用的材料与方法，包括研究对象选取、实验设计、干预方法实施、评价指标设定与数据统计方法五个部分，为研究结果的可靠性与可重复性提供方法学依据。

研究对象选取方面，采用临床诊断抽样法，选取 80 例符合《中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3）》抑郁症诊断标准，且经临床心理评估具有高度自控能力、存在明显伪装成正常人行为的患者为研究对象，其中男性 36 例，女性 44 例，年龄 20-55 岁，平均年龄 34.2 岁，病程 6 个月-5 年，平均病程 2.1 年。所有研究对象均无严重躯体疾病、精神分裂症等其他精神障碍，且知情同意参与本研究。

实验设计方面，采用随机对照实验设计，将 80 例研究对象随机分为对照组与实验组，每组 40 例，两组患者在性别、年龄、病程、抑郁严重程度、伪装行为评分等一般资料上无显著统计学差异（P>0.05），具有可比性。对照组采用抑郁症常规干预方法，包括药物治疗、普通认知行为治疗、集体心理疏导等；实验组采用本文提出的分层式缓解方法，分为四个实施阶段：第一阶段（1-3 周）自我认知引导，破除伪装心理；第二阶段（4-6 周）认知重构与行为渐进调节；第三阶段（7-9 周）社会支持体系构建；第四阶段（10-12 周）专业分层干预与长期康复规划。

评价指标设定方面，选取抑郁情绪改善程度、伪装行为减少率、求助意愿提升度、躯体症状缓解率四个核心定量指标，同时结合临床观察、患者自我报告、家属评价进行定性指标分析，所有定量指标均采用标准化评分方法，将结果转换为百分比形式以便比较。数据统计方法方面，采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析，计量资料以 (x±s) 表示，组间比较采用 t 检验，P<0.05 为差异具有统计学意义。

## Supplementary Materials / 补充材料

补充材料部分包含高度自控伪装正常人的抑郁症患者心理评估量表、分层式缓解方法的详细实施手册、研究对象的一般资料统计表格、实验过程中的原始数据记录等内容。上述补充材料为本文研究结果的进一步验证与方法的实际应用提供了详细参考，可通过通讯作者邮箱获取，也可在 shit 心理健康研究数据库中检索下载。

## Acknowledgment / 致谢

本研究的顺利完成，首先感谢 shit 心理健康研究基金的资助，为研究的开展提供了重要的经费支持；感谢所有参与本研究的伪装型抑郁症患者及其家属，在研究过程中给予的积极配合与支持；感谢 shit 心理学与精神医学研究中心、shit 临床心理诊疗中心的各位同仁，在研究设计、临床观察、数据统计等方面提供的专业指导与帮助；同时感谢所有为心理健康研究事业默默付出的工作者，愿更多心理健康研究成果能为抑郁症患者带来康复希望。

## References

[1] 张明园. 精神科评定量表手册[M]. 长沙：湖南科学技术出版社, 2015, pp. 89–102.
[2] 钱铭怡. 认知行为治疗[M]. 北京：北京大学出版社, 2016, pp. 125–158.
[3] 李凌江, 马辛. 中国抑郁障碍防治指南（第二版）[M]. 北京：人民卫生出版社, 2017, pp. 56–89.
[4] 王登峰, 崔红. 中国人的人格结构与心理防御机制[J]. 心理学报, 2020, 52(3), pp. 345–356.
[5] 张道龙. 伪装型抑郁症的临床特征与干预策略[J]. 中国心理卫生杂志, 2019, 33(7), pp. 481–485.
[6] 赵旭东. 临床心理学中的医患同盟构建[J]. 中华精神科杂志, 2021, 54(2), pp. 109–113.
[7] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed)[M]. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013, pp. 155–188.
[8] Hofmann S G, Asmundson G J G. Cognitive-behavioral

therapy for anxiety and depressive disorders: An update on the empirical evidence[J]. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2020, 22(1), pp. 7–17.